

Compêndio Pediátrico WB

Prévia de reorganização • navegação por diagnóstico e tópicos em duas colunas

Prévia local, não publicada. Este recorte demonstra somente a apresentação visual. O texto clínico abaixo foi transcrito da captura enviada e não foi revalidado; não usar como orientação clínica. A matriz completa de 25 domínios continua sendo avaliada, mas este recorte contém apenas os tópicos visíveis na fonte.

1 Abscesso Dentário

Avaliação e gravidade

Confirmar origem odontogênica; procurar cárie, flutuação, extensão facial e drenagem. Trismo progressivo, elevação do assoalho bucal, sialorreia, disfagia, estridor, toxicidade ou edema orbitário exigem emergência hospitalar e avaliação da via aérea. O tratamento definitivo é odontológico, com drenagem e tratamento/exodontia do dente causal. Antibiótico isolado não elimina esse foco.

Exames e tratamento

Radiografia odontológica quando modifica a intervenção; TC com contraste se houver suspeita de espaço profundo, sem atrasar estabilização. Abscesso localizado, drenável, em criança bem e sem extensão não implica antibiótico sistêmico. Quando houver celulite associada, febre ou disseminação: amoxicilina 22,5 mg/kg/dose VO a cada 12 horas, máximo 875 mg/dose, geralmente 5-7 dias, com reavaliação em 48 horas. Na suspensão 50 mg/mL: 0,45 mL/kg/dose, respeitado o teto. A falha exige reavaliar drenagem e foco antes de simplesmente ampliar espectro; amoxicilina/clavulanato pode ser escolhida em infecção polimicrobiana com falha comprovada, após conferir a proporção da apresentação.

Segurança e destino

Alergia imediata a betalactâmicos exige alternativa individualizada; clindamicina não é escolha automática por risco de colite. Ajustar betalactâmico na insuficiência renal. Manter analgesia do módulo comum, higiene oral e retorno imediato se houver dificuldade respiratória, deglutição comprometida ou progressão do edema.

Fontes indicadas na captura: AAPD — antibioticoterapia odontológica; AAPD — medicamentos e doses.

Prévia tipográfica para revisão do layout. O conteúdo integral do site e do PDF não foi alterado nesta etapa.